

Ondergetekende Dr. WOSTYN Lieven, specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise, en consulent Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde UZA, aangesteld als ARTS-GERECHTSDISKUNDIGE, **EXP2165726**, bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, K.16 gewezen op **18 november 2024**,

BURGERLIJKE PARTIJ

**Evelyne DELTOUR**

geboren op 31 maart 1979 te Roeselare,  
van Belgische nationaliteit,  
ingeschreven te Jozef Delbaerestraat 1, 8800 Roeselare

vertegenwoordigd door meester Julie VANDENBOGAERDE, advocaat te Kortrijk.

TEGEN BEKLAAGDE

**Jan FIEUW**

geboren op 1 april 1977 te Roeselare,  
van Belgische nationaliteit,  
ingeschreven te Zuidmolenstraat 3, 8800 Roeselare.

vertegenwoordigd door meester Laure VERVAEKE, advocaat te Kortrijk.

**MET ALS OPDRACHT :**

1. kennis te nemen van het strafdossier K04312.300/2024 en de medische stukken hem door partijen te bezorgen;
2. partijen per aangetekend schrijven en hun eventuele raadslieden per gewone post te verwittigen van de plaats, de dag en het uur van het deskundigenonderzoek;
3. zo dit nodig mocht blijken in de loop van het onderzoek, de gepaste specialisten te consulteren en hun advies en zijn oordeel desbetreffende bij het verslag te voegen;
4. de aard van de letsels (fysiek en psychisch) en de eventueel ondergane behandelingen te beschrijven en na te gaan of deze letsels in oorzakelijk verband staan met de feiten waarvoor de beklaagde werd veroordeeld;
5. zijn oordeel te geven nopens de aard, de duur en de evolutie van het genezingsproces en, in voorkomend geval, de duur van de hospitalisatie, alsook over de ernst van de geleden pijnen;

6. zijn advies te geven over de duur en de graden van de tijdelijke persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid;
7. zijn advies te geven over de graden van de blijvende persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid, de weerslag ervan op de beroepsactiviteit en/of op de andere levenssferen van het slachtoffer, hierbij rekening houdend met zowel de eventuele vooraf bestaande toestand als met het beroep van het slachtoffer;
8. zijn advies te geven over het tijdstip waarop het slachtoffer redelijkerwijs, weze het gedeeltelijk, zijn professionele en andere activiteiten kon hernemen en aan te geven of deze herneming van de activiteiten al dan niet met het leveren van meerinspanningen gepaard ging;
9. de datum van de consolidatie vast te stellen;
10. te bepalen of hulp van derden nodig is in de huishouding of daarbuiten, rekening houdend met de bestaande en beschikbare hulpmiddelen;
11. vast te stellen of de opgelopen letsels na de consolidatie nog medicatie en/of medische of paramedische behandelingen noodzakelijk of louter op comfort gericht zijn; desgevallend de aard en de termijn ervan te bepalen en de omvang van de eraan verbonden kosten te ramen; bij prothesen de noodzakelijke vernieuwingen te bepalen;
12. de gebeurlijke esthetische schade te beschrijven en zo mogelijk te bepalen volgens de gebruikelijke zevendelige schaal, bij voorkeur geïllustreerd door fotomateriaal; de eventuele weerslag van de esthetische schade op de uitoefening van de beroepsactiviteit te beschrijven;
13. advies te verstrekken over eventuele genoegenschade;
14. advies te verstrekken over eventuele seksuele schade;
15. te antwoorden op alle nuttige en ter zake dienende vragen die hem door de betrokken partijen worden gesteld.

Bepaalt dat dit vonnis door de griffier binnen de vijf dagen bij gerechtsbrief ter kennis zal worden gebracht aan de deskundige en per gewone brief aan de partijen en hun raadslieden.

Bepaalt dat de deskundige beschikt over een termijn van acht dagen na de kennisgeving van dit vonnis, om desgewenst de opdracht met behoorlijk omklede redenen te weigeren (artikel 972, §1, derde lid Ger.W.).

Bepaalt dat de deskundige en de partijen zich naar aanleiding van het deskundig onderzoek dienen te gedragen naar de bepalingen van de artikelen 962 tot 991bis Ger.W.

Stelt vast dat niet alle partijen om een installatievergadering hebben verzocht en acht een installatievergadering niet noodzakelijk.

Bepaalt dat als volgt moet worden gehandeld:

de voornoemde deskundige dient alle correspondentie aan de partijen aangetekend, en aan hun raadslieden, alsook aan de verder in onderhavig vonnis met de opvolging en controle van de deskundige werkzaamheden aangewezen rechter, per gewone brief te versturen. Voor wat betreft de correspondentie te voeren na de mededeling van de plaats, de dag, en het uur van de aanvang van de deskundige werkzaamheden, (met uitzondering wat betreft de mededeling van het eindverslag, waarover verder meer) kan de deskundige eventueel door de partijen worden vrijgesteld van de verplichting om per aangetekende post te corresponderen;

- de deskundige dient binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving van dit vonnis —en voor zover hij de opdracht niet weigert — de partijen, hun raadslieden evenals de verder in huidig vonnis met de opvolging en controle van de deskundige werkzaamheden aangewezen rechter schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn aanvaarding van de opdracht;
- samen met de hiervoor vermelde schriftelijke kennisgeving van aanvaarding van de opdracht, maakt de deskundige aan dezelfde geadresseerden schriftelijk een raming over van de algemene kostprijs van het deskundigenonderzoek of minstens van de manier waarop en de tarieven waaraan zijn kosten en ereloon, alsook de kosten en het ereloon van de eventuele technische raadgevers zullen berekend worden;
- de deskundige dient daarna te wachten op de kennisgeving van de consignatie van het voorschot door de griffier, zoals verder in onderhavig vonnis bepaald;

binnen een termijn van vijftien dagen nadat hem door de griffier werd kennis gegeven van de consignatie van het voorschot, dient de deskundige zelf de plaats, de dag, en het uur te bepalen waarop hij zijn werkzaamheden zal aanvangen. Binnen dezelfde voormelde termijn dient hij die gegevens schriftelijk aan de partijen, hun

raadslieden en aan de rechter mede te delen;

de partijen dienen ten laatste acht dagen voor de eerste bijeenkomst bij de deskundige een geïnventariseerd dossier met alle relevante stukken aan de voornoemde deskundige over te maken, conform artikel 972bis, §1, tweede lid Ger.W. (en deze op hetzelfde voormelde ogenblik eveneens mede te delen aan alle wederpartijen —voor zover dit nog niet vroeger zou gebeurd zijn);

- de deskundige zal in de loop van zijn opdracht zelf bepalen of het noodzakelijk is om al dan niet een beroep te doen op technische raadgevers;
- alle verrichtingen dienen tegensprekelijk te gebeuren en alle partijen dienen opgeroepen te worden om daar deel aan te nemen, tenzij de partijen de deskundige hiervan zouden vrijstellen gelet op het uiterst technische karakter van sommige verrichtingen;

zegt dat de beklaagde de verrichtingen van de deskundige niet in persoon mag bijwonen, maar wel een geneesheer naar keuze mag aanstellen om de expertise bij te wonen, onveranderd zijn recht op vertegenwoordiging door een advocaat;

- de minuut van het met redenen omkleed eindverslag, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke voorschriften krachtens artikel 978, § 1 Ger.W., dient, samen met de gedetailleerde staat van kosten en ereloon van de deskundige (en eventueel geraadpleegde technische raadgever(s)), conform artikel 990 Ger.W., neergelegd te worden op de correctionele griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, met afschrift per aangetekend schrijven aan partijen en per gewone brief aan de raadslieden.
- het eindverslag dient door de deskundige op straffe van nietigheid te worden ondertekend en afgesloten met de wettelijke eedformule: "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen".

#### **BEVESTIGT :**

deze opdracht te hebben vervuld, en behoorlijk de partijen te hebben verwittigd van de plaats, dag en uur van het deskundig onderzoek, meer bepaald :

In het kabinet van ondergetekende, Lostraat 10 te Aalter, op **maandag 3 februari 2025 om 13 uur**, deze zitting werd verdaagd;

In het kabinet van ondergetekende, Lostraat 10 te Aalter, op **vrijdag 7 maart 2025 om 12 uur**;

In het kabinet van ondergetekende, Lostraat 10 te Aalter, op **vrijdag 14 maart 2025 om 9 uur**, deze zitting werd verdaagd.

Waren aanwezig op deze zitting:

**Evelyne DELTOUR – slachtoffer**

**Dr. Jan GODDYN – raadsgeneesheer**

**Dr. Lieven WOSTYN – gerechtsdeskundige**

**Fien DESART – administratief medewerker**

Tijdens deze zittingen werden de personalia, de persoonlijke anamnese, de medische antecedenten, en de beschrijving van de feiten en de evolutie van de letsels na de feiten doorgenomen, inzonderheid in welke mate de duur van de ongeschiktheid in causaal verband met het ongeval staat.

Er werd een klinisch onderzoek uitgevoerd.

#### **INVENTARIS EN VERLOOP VAN DE VERRICHTINGEN**

1. Schrijven ontvangen d.d. 28 november 2024 van mevrouw de griffier E. DE ROOSE met in bijlage vonnis aanstelling deskundige;
2. Schrijven d.d. 28 november 2024 gericht aan partijen (aangetekend) en raadslieden (gewoon) met mededeling aanvaarden opdracht en vraag naar alle nuttige medische stukken en gegevens raadsgeneesheer;
3. Schrijven (mail) d.d. 30 november 2024 ontvangen van de tegenpartij de heer FIEUW met vraag of het causaal verband onderzocht zal worden tussen de geweldpleging en de psychische toestand van betrokkene en vraag of hij de conclusies mag afwachten en later kan beslissen of hij al dan niet beroep zal doen op een raadsgeneesheer;
4. Provisie ontvangen op 13 december 2024;
5. Schrijven d.d. 13 januari 2025 gericht aan partijen (aangetekend) en raadslieden (gewoon) met mededeling plaats- en datum (eerste) expertisезitting;

6. Schrijven (mail) d.d. 28 januari 2025 ontvangen van Meester VANDENBOGAERDE met mededeling dat betrokkene zich zal laten bijstaan door de heer Jan GODDYN en de geplande expertisезitting niet door zal kunnen gaan;
7. Schrijven d.d. 31 januari 2025 gericht aan partijen (aangetekend) en raadslieden (gewoon) met mededeling plaats- en datum (eerste) expertisезitting;
8. (Eerste) expertisезitting op maandag 3 februari 2025, deze zitting werd verdaagd;
9. Schrijven (mail) d.d. 7 februari 2025 ontvangen van Meester VANDENBOGAERDE met mededeling dat betrokkene aanwezig zal zijn op de geplande zitting van 7 maart 2025;
10. Schrijven (mail) d.d. 3 maart 2025 ontvangen van Meester VANDENBOGAERDE met ingesloten het verslag van de heer GODDYN;
11. (Eerste) expertisезitting op vrijdag 7 maart 2025 om 12 uur,
12. (Eerste) expertisезitting op vrijdag 14 maart 2025 om 9 uur, deze zitting werd verdaagd;
13. Overmaken voorverslag op 17 maart 2025.

## **INHOUDSOPGAVE**

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PERSONALIA .....</b>                                    | <b>8</b>  |
| <b>2. MEDISCHE EN ANDERE ANTECEDENTEN .....</b>               | <b>8</b>  |
| <b>3. FEITEN, LETSELS EN BEHANDELING .....</b>                | <b>9</b>  |
| <b>4. HUIDIGE KLACHTEN EN KLINISCH ONDERZOEK .....</b>        | <b>12</b> |
| <b>4.1. KLINISCH ONDERZOEK .....</b>                          | <b>12</b> |
| 4.1.1. Klinisch onderzoek CWZ .....                           | 13        |
| 4.1.2. Klinisch onderzoek bovenste ledematen .....            | 13        |
| 4.1.3. Klinisch onderzoek dorsale en lumbale wervelzuil ..... | 14        |
| 4.1.4. Klinisch onderzoek onderste ledematen .....            | 14        |
| <b>5. ALGEMEEN LOCOMOTORISCH ONDERZOEK .....</b>              | <b>14</b> |
| <b>6. ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ONDERZOEK .....</b>              | <b>15</b> |
| <b>7. BESPREKING: .....</b>                                   | <b>15</b> |
| <b>8. BESLUIT: .....</b>                                      | <b>15</b> |

## **1. PERSONALIA**

**Evelyne DELTOUR**

### Huidig beroep:

Handelsvertegenwoordiger bij Dupont Sanitair te Roeselare.

### Opleiding:

Logopedie

### Voorgaande beroepen:

Betrokkene was samen met ex-partner zaakvoerder van "Kids&Co", een kinderspecialzaak in de Westlaan te Roeselare. Deze zaak ging failliet.

### Familiaal

Alleenstaand, gescheiden, drie kinderen (20, 17 en 14 jaar oud) thuiswonend.

### Vrijetijd

Sporten, lezen, koken en werken.

## **2. MEDISCHE EN ANDERE ANTECEDENTEN**

### Medische antecedenten

|                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziektes:              | Geen ziektes of allergieën gemeld                                                                                                                                                                                  |
| Operaties:            | Kruisbanden knie<br>Drie maal sectio                                                                                                                                                                               |
| Chronische medicatie: | Voor de feiten nam betrokkene geen medicatie.<br>Sedert de feiten: Trazodone 25mg (voor het slapen gaan) en Escitalopram.                                                                                          |
| Psychiatrie:          | Op heden tweewekelijks consult bij psycholoog Joke HELLIN (zie hieronder meer). Zij luistert vooral en biedt inzichten die betrokkene zelf niet heeft door verdriet en angst.<br>Nooit bij een psychiater geweest. |
| Gewicht:              | 60 kg                                                                                                                                                                                                              |

Lengte: 1 m 63

### **3. FEITEN, LETSELS EN BEHANDELING**

Op **7 januari 2024** werd betrokkene het slachtoffer van slagen- en verwondingen, toegebracht door diens ex-man.

De ex-man van betrokkene drong haar woning binnen te Rumbeke. Zij werd vervolgens geheel onverwachts en op brutale wijze fysiek aangevallen. Betrokkene was aan het eten toen de bel ging, ze deed de deur open en haar ex-man drong direct binnen en begon betrokkene te slaan, betrokkene struikelde naar achteren, de dader zat op haar. Het geweld stopte pas bij tussenkomst van een derde, de toenmalige partner van betrokkene. Hij heeft de dader toen buitengezet. De dader was onder invloed van alcohol. De aanval kwam geheel onverwachts en duurde volgens betrokkene slechts een vijftal minuten.

Op **7 januari 2024** werd betrokkene gezien op de spoedgevallendienst van de St-Jozefs kliniek Izegem door Dr. P VAN DE SIJPE. Wonde dicht geniet. Verslag ontbreekt.

Op **10 januari 2024** werd psychologische begeleiding voorgeschreven door huisarts Dr. E. UYTTERSROT.

Op **15 augustus 2024** werd betrokkene opgenomen op de dienst spoedgevallen, uitgelokt door stress. Zij kon niets meer onthouden, vroeg meermaals hetzelfde en vergat alles. Uit onderzoek bleek dat zij een TGA (*transient global amnesia*)<sup>1</sup> doormaakte.

Betrokkene gaf een korte uiteenzetting van die dag: Zij kwam thuis nadat ze bij een vriendin was blijven slapen. Ze vroeg haar dochters continu dezelfde zaken, zij maakten zich zorgen. Betrokkene belde toen naar een vriend, hij was ook ongerust. Diezelfde vriend begaf zich toen naar de woning van betrokkene en ging met haar naar het ziekenhuis. Betrokkene heeft het gevoel dat haar hoofd vol was en het te veel werd toen. Kan zich niet veel herinneren van die dag, is vooral wat aan het verteld werd door omstaanders. Geen verslag.

Op **19 september 2024** werd betrokkene gezien op de raadpleging neurologie in de St-Jozefs kliniek te Izegem door Dr. A. VANHOORNE.

Het besluit luidde als volgt:

---

<sup>1</sup> TGA is een syndroom dat zich kenmerkt door een acuut optredend algeheel geheugenverlies. Er is zowel sprake van een retrograad als anterograd geheugenverlies. Retrograad geheugenverlies houdt in dat er geen herinnering is van de tijd voorafgaand aan de TGA. Anterograd geheugenverlies betekent dat het onmogelijk is om iets nieuws te leren of informatie op te slaan. Emotionele stress is een mogelijke risico-factor.

*'Verhaal van transient globale amnesie gedurende enkele uren, met nadien goede recuperatie. Er is een langer bestaande context van stress en emotionaliteit, die wellicht de episodes heeft uitgelokt. Het EEG vandaag toont geen epileptische afwijkingen. MR hersenen wordt voor alle zekerheid nog gepland, maar de kans op doorgemaakte ischemie lijkt mij zeer laag. Asaflow en statine kunnen terug gestaakt worden. De recidiefkans van TGA is erg laag. Wel best jaarlijks labo bij de huisarts ter opvolging van cholesterol in primaire preventie. Ik plan een belafsprak na de MR hersenen.'*

Op **30 september 2024** onderging betrokkene een MRI van de hersenen in de St-Jozefs kliniek te Izegem.

Conclusie: *'Normaal onderzoek van de hersenen. Geen ischemische letsels, ruimte-innemende processen of witte stofletsels suggestief voor encefalitis.'*

Op **3 oktober 2024** nam Dr. A. VANHOORNE, neuroloog in de St-Jozefs kliniek te Izegem contact op met betrokkene. Normale MR hersenen, wat andere mimics van TGA verder uitsluit. Patiënte werd gerustgesteld. De recidiefkans is laag.

Op **27 februari 2025** werd betrokkene gezien door de heer J. GODDYN en mevrouw I. GODDYN.- in het Psychologisch Ergologisch Expertise Centrum.

Zijn besluit luidde als volgt:

*'Het onderzoek bij mevrouw Evelyne Deltour komt tot volgende vaststellingen : Het aandachtsonderzoek toont aan dat er voor de gerichte aandacht noch voor de gespreide aandacht problemen rijzen. Het concentratievermogen (hoe goed iemand zich voor langere tijd kan focussen) is verminderd. Het opslaan en ophalen van informatie verloopt vlot, zowel wat betreft het korte termijn geheugen (werkgeheugen), het lange termijn geheugen en het proceduraal geheugen (vaardigheden). De perceptie (interpretatie van zintuiglijke informatie) is deugdelijk. Op persoonlijkheidsvlak ontwaren we gevolgen, die gerelateerd kunnen worden aan de feiten van 7 januari 2024. Er is een emotionele belasting die verband houdt met het sociale coping-mechanisme. Stress-reacties met de karakteristieke stemmingsveranderingen (angst, depressie, insufficiëntie van denken en handelen) staan hierbij centraal. De risicosituatie is niet verwerkt, er is een verhoogd waakzaam wantrouwen. Dit betekent samengevat een aantasting van de levenssfeer.'*

### **Arbeidsongeschiktheid:**

In het verslag van Dr. P. VAN DE SIJPE d.d. 7 januari 2024 werd volgende periode van arbeidsongeschiktheid weerhouden:

100%                      8 januari 2024 tot en met 10 januari 2024

In het verslag van Dr. E. UYTTERSROT d.d. 10 januari 2024 werd volgende periode van arbeidsongeschiktheid weerhouden:

100%                      11 januari 2024 tot en met 14 januari 2024

**Psychiatrie:**

In het verslag van psycholoog mevrouw J. HELLIN d.d. 1 juli 2024 lezen we dat betrokkene sedert 1 februari 2024 bij haar in begeleiding is naar aanleiding van de geweldpleging door haar ex-partner in januari. Evelyne ervaart sedert het geweldincident emotionele moeilijkheden (angst, prikkelbaarheid, hyperalertheid), haar zelfbeeld is negatief en in relatie tot anderen in haar omgeving heeft zij last van verlatingsangst.

Evelyne kwam langs op volgende momenten en is op heden nog steeds in behandeling:

- 01-02-2024
- 06-02-2024
- 15-02-2024
- 19-02-2024
- 29-02-2024
- 11-03-2024
- 20-03-2024
- 08-04-2024
- 23-04-2024
- 07-05-2024
- 23-05-2024
- 06-06-2024

In het verslag van psycholoog mevrouw J. HELLIN d.d. 15 oktober 2024 lezen we dat betrokkene nog steeds in behandeling is en rond bovenstaande thema's aan het werk zijn:

Evelyne kwam langs op volgende momenten:

- 15-07-2024
- 14-07-2024
- 29-08-2024
- 12-09-2024
- 23-09-2024
- 07-10-2024

**Aantal sessies kinesist**

Niet van toepassing.

#### **4. HUIDIGE KLACHTEN EN KLINISCH ONDERZOEK**

##### Subjectieve klachten:

- Zware emotionele moeilijkheden (angst, prikkelbaarheid en hyperalert);
- Laag zelfbeeld;
- Leeft in angst, ondanks voorwaarden waaraan de dader zich momenteel aan moet houden (zoals contactverbod en onthouding alcohol) toch schrik voor wat er in de toekomst zal komen, 'wat over vier jaar'.
  - o De dader lijdt aan een bipolaire stoornis en kent een verleden van alcohol- en middelenmisbruik, betrokkene heeft schrik, gezien hij zeer onvoorspelbaar is.
  - o Hij leeft naar eigen zeggen in wrok, de scheiding is reeds elf jaar geleden, waarvan de dader reeds vijf à zes jaar een vaste partner heeft;
  - o De dader woont dichtbij. Ze zal op de parking van de winkels en tussen de *rayons* bijvoorbeeld steeds kijken of hij niet aanwezig is;
  - o Veel rustiger wanneer ze weet dat hij er niet is, bijvoorbeeld toen hij met de kinderen in Parijs was;
- Verlatingsangst, schrik om mensen te verliezen omdat ze niet goed genoeg doet (had dit voor de feiten niet);
- Moeilijkheden met geheugen;
- Moeilijk slapen;
- Nachtmerries, droomt soms dat hij terug in haar huis staat;
- Lange concentratie moeilijk. Zij kan hierdoor haar job moeilijker uitoefenen, kost haar meer moeite. Hierdoor is betrokkene ook vaker moe wanneer ze thuis komt na het werk. Gelukkig wel goede collega's die haar helpen;
- Argwanend;
- Betrokkene gaat sedert de feiten gebukt onder zeer veel stress;
- Heeft schrik om de dader nog kwader te maken, vreest voor meer agressie dan;
- Fysiek geen letsels.

##### **4.1. KLINISCH ONDERZOEK**

##### Algemeen

De procedure wordt uitgelegd.

Fenotype congruent met de kalenderleeftijd.

### **Staand**

Geen asymmetrie in supraclaviculaire fossae.

Positie van het hoofd: normaal.

Prominentie doornuitsteeksel C7: normaal.

Schouderhoogte en reliëf schouderbladen: gelijk links en rechts.

Het reliëf van de doornuitsteeksels: normaal.

Cervicale en lumbale lordose: normaal.

Er is geen dorsale kyphose.

Symmetrie van de repaires ter hoogte van het bekken en de tailedriehoeken.

Unipodale stand bilateraal mogelijk.

### **Hoofd**

Visusstoornissen: isocorie, normale lichtpupilreflexen, normale oogmotiliteit, geen nystagmus, normale vingerperimetrische gezichtsvelden.

Geen drager van corrigerende glazen.

Normale mimiek en functie van de facialismusculatuur.

Geen dysfonie of dysfagie.

Geen littekens

#### **4.1.1. Klinisch onderzoek CWZ**

Flexie: afstand tot sternum is 0 cm

Extensie: normale range, volledig (kin-manubrium 20 cm)

Dextroflexie: 50°

Sinistroflexie: 50°

Rotatie naar rechts: volledig

Rotatie naar links: volledig

#### **4.1.2. Klinisch onderzoek bovenste ledematen**

De tonus van de bovenste ledematen is normaal. De kracht waarmee de verschillende bewegingen van de bovenste ledematen kunnen worden uitgevoerd, is normaal.

| <b>Beweeglijkheid van de schouder</b> | <b>R</b> | <b>L</b> |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Anteropulsie                          | 180      | 180      |
| Retropulsie                           | 45       | 45       |
| Abductie                              | 180      | 180      |
| Externe rotatie                       | 50       | 50       |
| Interne rotatie                       | 120      | 120      |

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| Painful arc | afwezig | afwezig |
|-------------|---------|---------|

| <b>Beweeglijkheid van de elleboog</b> | <b>R</b> | <b>L</b> |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Flexie                                | 140      | 140      |
| Extensie                              | 0        | 0        |
| Pronatie                              | 75       | 75       |
| Supinatie                             | 75       | 75       |

Palmaire flexie, dorsale flexie, radiale en ulnaire deviatie: symmetrisch.

Vinger en duimen: mobiliteit symmetrisch.

Test duim-wijsvinger: bilateraal symmetrisch. Normale gevoeligheid in het  
enervatiegebied van de arm- en handzenuwen bilateraal

#### **4.1.3. Klinisch onderzoek dorsale en lumbale wervelzuil**

- o Palpatie van de paravertebrale spieren is soepel, geen pijn wordt aangegeven
- o Bekloppen processus spinosi wordt niet als pijnlijk aangegeven
- o Flexie: conform leeftijd  
Extensie: normale range
- o Dextroflexie: vingers reiken tot de gewrichtsspleet  
Sinistroflexie: vingers reiken tot de gewrichtsspleet
- o Rotatie naar rechts: rechtstaand 90°  
Rotatie naar links: rechtstaand 90°

#### **4.1.4. Klinisch onderzoek onderste ledematen**

Bij inspectie van de heupen en knieën zien we geen afwijkingen.

### **5. ALGEMEEN LOCOMOTORISCH ONDERZOEK**

- o Inspectie:  
Er is geen hyperkinesie.  
Er is geen hypokinesie.
- o Staan en gaan:  
Teengang, hielgang: normaal
- o Koorddansersgang: stabiele gang.  
Romberg: negatief.
- o Hurken: normaal
- o Geen hypermetrie, geen dysmetrie

- o Armen:  
Dysdiadochokinese: normaal.  
Vingertop-neusproef: normaal.
- o Dysartrie: afwezig.

## **6. ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ONDERZOEK**

Tijdens ons onderzoek zien we een vrouw die coöperatief is. De concentratie is niet lang vol te houden. Het onmiddellijke geheugen is niet verminderd. Adequate verwerkingssnelheid. Executieve functies in het cognitief domein scoren goed. Normale mentale en cognitieve flexibiliteit. Normaal perceptueel-motorisch vermogen.

Zij vertoont tijdens het onderzoek wel emotionele stress, geen manie, geen onrust.

De gedachtegang is coherent en de gedachteninhoud is adequaat.

Er zijn geen hallucinaties of waandenkbeelden.

Geen paranoïde kenmerken.

Geen psychose.

Geen ADHD.

PTSS.

Posttraumatische stressstoornis cfr.DSM-V: herbeleving van een mogelijks fatale beleving, nachtmerries, sociaal geïnhibeerd.

## **7. VOORVERSLAG**

Het voorverslag wordt overgemaakt op 17 maart 2025 met de vraag opmerkingen over te maken voor 17 april 2025.

## **8. BESPREKING en BESLUIT:**

Volgend **advies** kan verleend worden en dit naar aanleiding van de feiten van **DELTOUR Evelyne** haar overkomen op **7 januari 2024**:

Hoofdwonde gehecht. Geen litteken zichtbaar.

Posttraumatisch stresssyndroom: cfr.DSM-V: herbeleving van een mogelijks fatale beleving, nachtmerries, sociaal geïnhibeerd. Zie Europese schaal voor de beoordeling van aantastingen van de fysieke en psychische integriteit. B) Psychiatrie b) traumatische neuroses (posttraumatische stress) fobische angstmanifestaties met ontwijkend gedrag en herhalingsyndroom (3 à 8 %). Weerslag op het werk.

Consolidatiedatum:

**7 januari 2025**

**Blijvende economische ongeschiktheid** 5 %

**Blijvende persoonlijke ongeschiktheid** 5 %

**Blijvende huishoudelijke ongeschiktheid** 0 %

**Tijdelijke economische ongeschiktheid:**

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 100% | 8 januari 2024 tot en met 14 januari 2024   |
| 20 % | 15 januari 2024 tot en met 30 augustus 2024 |
| 10 % | 1 september 2024 tot en met 6 januari 2025  |

**Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid:**

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 100%  | 8 januari 2024                                |
| 20 %  | 9 januari 2024 tot en met 14 januari 2024     |
| 100 % | 15 augustus 2025                              |
| 20 %  | 16 augustus 2025 tot en met 30 september 2024 |
| 10 %  | 1 oktober tot en met 6 januari 2025           |

**Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid:**

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 100%  | 8 januari 2024                                |
| 20 %  | 9 januari 2024 tot en met 14 januari 2024     |
| 100 % | 15 augustus 2025                              |
| 20 %  | 16 augustus 2025 tot en met 30 september 2024 |
| 5 %   | 1 oktober tot en met 6 januari 2025           |

Behandeling na de consolidatiedatum: 15 sessies cognitieve gedragstherapie en escitalopram en trazodone voor 3 jaar op voorschrift/factuur.

Voorbehoudende voor de toekomst: geen

Geen genoegschade

Geen hulp van derden

Geen seksuele schade

Esthetische schade : schaal van 0 op 7

**"Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heb vervuld."**

Dit verslag telt 17 genummerde bladzijden.

Aalter, 17 maart 2025

Dr. Lieven WOSTYN

EXP2165726  
Master in de rechten  
Specialist in de medische expertise en verzekeringsgeneeskunde  
EXP2165726  
BAP UAntwerpen/Fellow Law and Criminology VUB  
Consulent Centrum voor gerechtelijke geneeskunde UZA